

## COLECISTITIS AGUDA

*Cristina Ferrero Sanz, Diana João Matias, Laura Rodríguez Martín.*

### INTRODUCCIÓN

Inflamación de la pared de la vesícula biliar por obstrucción del conducto cístico por un cálculo biliar (90-95%) o alitiásica (5%-10%). Los gérmenes más frecuentes pueden ser E. Coli, Klebsiella y anaerobios (bacteroides frágiles y Clostridium). Los pacientes diabéticos e inmunodeprimidos son más susceptibles a infección por anaerobios.

Estadios de evolución de la colecistitis aguda según el curso clínico.

- **Colecistitis edematosa.** 2º-4º día, se genera una dilatación de vasos linfáticos y de capilares, llenándose la vesícula de líquido intersticial, presenta edema de la pared con tejido intacto específicamente hay edema subseroso.
- **Colecistitis necrótica.** 3er -5º día, hay cambios edematosos en la vesícula con zonas hemorrágicas y necrosis superficial sin llegar a incluir toda la pared de la vesícula.
- **Colecistitis supurativa.** 7º- 10º día. Aparecen abscesos intramurales con zonas necróticas.
- **Colecistitis crónica.** Tras episodios repetitivos de colecistitis aguda, la pared de la vesícula presenta engrosamiento y fibrosis con atrofia de la mucosa.

### DIAGNÓSTICO

- **Síntomas/signos:** Dolor intenso en hipocondrio derecho con defensa, fiebre, Signo de Murphy positivo, ictericia. El paciente refiere dolor intenso y continuo en hipocondrio derecho o epigastrio, pudiendo estar irradiado al hombro derecho o espalda, además pueden presentar: náuseas, vómitos, malestar general y anorexia. Refieren antecedente de ingesta de alimento copiosas con grasa
- **Analítica sanguínea:**
  - **Hemograma.**
  - **Coagulación básica.**
  - **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, bilirrubina, aspartato aminotransferasa (AST/GOT), alanina aminotransferasa (ALT/GPT), gamma glutamiltranspeptidasa (GGT), fosfatasa alcalina (FA), lactato deshidrogenasa (LDH), amilasa, proteína C reactiva (PCR), procalcitonina (PCT). Podemos encontrar leucocitosis con desviación izquierda, elevación de PCR, aumento de bilirrubina, alteración de las pruebas de función hepática, elevación de amilasa. En colecistitis aguda no complicada no debería de haber elevación de bilirrubina o fosfatasa alcalina, si existiera elevación debemos de sospechar complicaciones: colangitis, coledocolitiasis o **síndrome de MIRIZZI** (cálculo enclavado/impactado en el infundíbulo de la vesícula o la porción distal del conducto cístico, produciendo compresión extrínseca de la vía biliar).
- **Radiografía de Abdomen:** aerobilia, gas perivesicular.
- **Ecografía abdomen.** Prueba de elección, tiene una sensibilidad de 88% y especificidad del 80%, se puede realizar el diagnóstico ecográfico cuando existe:
  - Murphy ecográfico positivo
  - Engrosamiento de la pared vesicular >3mm.
  - Líquido perivesicular.

- Otros menos específicos: colelitiasis, barro biliar y dilatación de la vesícula.
- **TAC Abdominal:** Es útil cuando se sospecha complicaciones o se desea descartar otras causas abdominales. Se puede apreciar:
  - Engrosamiento parietal.
  - Distensión vesicular.
  - Edema de pared con patrón en capas.
  - Colección perivesicular.
  - Hidrops vesicular.
  - Áreas de alta densidad en grasa perivesicular.
  - Presencia de abscesos y gas en la pared y en la vía biliar (fístula biliar).

## TRATAMIENTO

- Canalizar vía venosa periférica.
- Constantes vitales: TA, FC, FR, SatO2, glucemia.
- Dieta absoluta y sueroterapia
- Protector gástrico: pantoprazol 1 amp IV cada 24h.
- Analgesia si precisa según escala visual analógica del dolor (EVA) y antieméticos: paracetamol 1 gr IV cada 8h. Metoclopramida 1 amp IV cada 8h si náuseas o vómitos.
- Antibioterapia empírica:
  - Formas leves: amoxicilina/clavulánico: dosis inicial 2g iv; dosis de mantenimiento: 1g iv/8 horas. O bien Ceftriaxona 2g iv/24h
  - Formas graves: piperacilina/tazobactam: 4/0.5 g iv/6 horas. O bien Meropenem 1 g iv cada 8 horas
- Interconsulta a cirugía de guardia. La colecistectomía precoz (< 72 horas) es la mejor opción en los pacientes con un riesgo quirúrgico aceptable.

## BIBLIOGRAFÍA

- M.A. Montoro Huguet; JC. García Pagán. Práctica clínica en Gastroenterología y Hepatología. Vol II. 1ª ed. Madrid. CTO editorial. 2016. Cap. 53 y 57.
- F. Aguilar Rodríguez; O. Bisbal Prado; C. Gómez Cuervo; M. de Lagarde Sebastián; G. Maestro de la Calle; M. A. Pérez-Jacoiste Asín; J. Llenas García; L. Pérez Ordoño; J. Villa Santos. Manual diagnóstico y terapéutica médica 12 de Octubre. 8ªEd. Madrid. MSD. 2016. Cap. 51 y 58.
- L. Jiménez Murillo; FJ. Montero Pérez. Medicina de Urgencias. Guía terapéutica. 3ª ed. Barcelona. Elsevier. 2011. Cap. 35.